جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زنوبه احمد نجم محمد نجم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** الجيزة
رقم البطاقة : 27709062100983 **رقم التليفون :** 01143440147 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-09-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب تحت الجلد و بيرتوزوماب(فيسجو) [14117] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: زينه احمد نجم محمد نجم
National ID: 27709062100983

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Phesgo) Subcutaneous trastuzumab and pertuzumab)

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



زنوبه
احمد نجم محمد نجم
١٦ مسجد منسى-داير الناحية-جزيرة محمد
الوراق - الجيزه

٢٧٧٠٩٠٦٢١٠٠٩٨٣

١٩٧٧/٠٩

LA6348936



٢٧٧٠٩٠٦٢١٠٠٩٨٣ ٢٠٢٥/٠٣
بدون عمل



انثى مسلمة متزوجة
محمود رياض محمد محمود
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٢/٢٨



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

06/21/2026

MDT FORM

Name:	زينب احمد نعيم محمد	**MRN:**	9148
Age:	49 Y	**ID:**	27709062100983
Menopausal Status:	post	**Phone:**	01153055035
NRS SCORE:		**Marital Status:**	married
BMI:		**Family History:**	-ve
CO Morbidity:	n free	**Reason Of MDT:**	new

Clinical Data:

BX: LT IDC 2

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 3+ **KI67:** 20%

Sonomammography:

CESM two enhancing masses + PLN

Mets Workup:

CT CAP free

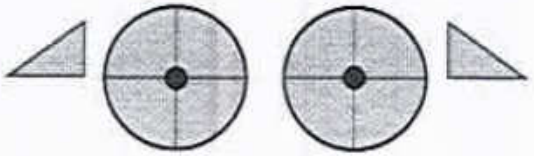
History:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

being multicentric
for neoadj TCHP 6 cycles then MRM/ALND

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr Hanan Ezzat	Dr Ahmed Nagiub				

Name: زنوبه احمد نجم محمد	
MR. : 9148	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

49YO M:FREE ON IUD BX:LEFT IDC TRIPLE +VE BSM:LOQ MASS 2.3 CM FROM NIPPLE CESM:Right breast: * Low energy (Non contrast) images: middle 1/3 LIQ &LOQ irregular shaped spiculated dense lesions associated with architectural distortion. * Recombined (Post contrast) images: o LOQ middle 1/3 irregular spiculated heterogenous moderate conspicuity mass enhancement measuring about 4.7 x 6 x 2.9 cm at its AP, TS and CC diameters and about 3.5 cm from the nipple (Index lesion,). * LIQ middle 1/3s irregular spiculated heterogenous moderate conspicuity mass enhancement measuring about 2.7 x 3.6 x 1.4 cm at its AP, TS and CC diameters and about 4.5 cm from the nipple * Complementary US: o large irregular shaped spiculated hypochoic lesion located from 3-6 clock position o similar smaller from 8-9 o'clock is noted * Few enlarged axillary lymph node at level I with focal cortical thickening, largest one measuring about 24 x 19 mm with focal cortical thickening measuring about 10MM(MULTICENTRIC) CTCAP: MEDIASTINAL LN 12*11MM TO BE ASSESSED IN MDT AFTER BONE SCAN WETHER METASTATIC OR NOT BONE SCAN REQUESTED CLINICALLY T3(MULTICENTRIC) N2 MX WITH PALPABLE PARAEROLAR NODULE SUPERIOR TO INDEX MASS

Bone scan 5/2026: Free , MDT 29/6/2026 being multicentric for neoadj TCHP 6 cycles then MRM/ALND, pending HP approval, echo and labs will be done for date in chemo clinic.

cT4b N2 M0 o/e skin edema erythema and thickness (peau d'orange) for taxotere carboplatin auc5 c1, after labs, pending HP approval, for proph neupogen + methabiogen

clinical pharmacy note : c1 txt carbo was postponed on 13/8 due to low hb 7 so todaty for c1 txt 140 carbo auc5 after blood transfusion wt 70 ht 158 sa 1.75

prem left breast cancer ct4b n2 mo cts med ln 12x11 bs free idc er8/8 pr8/8 her23+ ki 20% on exam left breast edema redness left ax ln 2x2 hb 7.8 for blood transfusion and repeat cbc tommorrow

hb 8.6 for c3 taxotere 140 carbopl auc 5 and 1 proph neupogen

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

Name : Zanouba Ahmed Nagm Mohammed
Date : 18-05-2026 08:44
Branch : Dokki
Medical No. : 377452
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt
Ins.Company : تعاقد مستشفيات

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

CLINICAL HISTORY & INDICATION:

- 48-year-old female patient with history of breast cancer; referred for metastatic workup.

TECHNIQUE

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 – 3 hours post injection of 20 mCi of Tc-99m MDP.

FINDINGS

- The skeletal system demonstrates physiological radiotracer distribution with normal uptake in the axial and appendicular skeleton.
- No focal abnormal areas of increased or decreased tracer uptake could be identified to suggest skeletal metastatic deposits on scintigraphic basis.
- Expected age-related degenerative changes at different levels of the spine and around big joints without suspicious metastatic pattern.

IMPRESSION

- No scintigraphic evidence of skeletal metastases on whole-body bone scan.
- Follow-up imaging only if clinically indicated.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

٩١٤٨

Name : ZANOUBA AHMED	Date : 20-01-2026 12:01
Branch : Portable	Medical No. : GRI-200126115947AM
Ref.Physician Prof :	Ins.Company :

BILATERAL DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH RESOLUTION BREAST SONOGRAPHY REVEALED:

CLINICAL SUMMARY:
Left breast palpable lump

FINDINGS:

LEFT BREAST:

- Dense parenchyma, (ACR C).
- The LOQ is the seat of a spiculated mass, associated with subtle skin thickening.
- Complimentary U/S demonstrated an underlying heterogenous hypoechoic mass located at 3-4 o'clock, measuring about 4x2.7cm, laying 0.2cm deep to the skin and 2.3cm away from the nipple.
- Level I and II pathological axillary nodes are seen, with cortical thickness reaching 6mm.
- Free infra and supra-clavicular regions.

RIGHT BREAST:

- Dense parenchyma, (ACR C).
- No mass, spiculation or suspicious micro calcifications, this was further confirmed by and U/S examination.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non specific axillary nodes are noted.

CONCLUSION:
Left breast (BIRADS 4c): LOQ malignant mass as described
Right breast (BIRADS 1): normal study

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast LOQ mass, BIRADs 4c.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 04/02/2026, at 12:50 pm.

Gross Examination:
- Four fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm. Totally submitted.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* Ductal carcinoma in situ: Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern).
* Angioinvasion: Absent.
* Perineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 75% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 20%.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Focal Intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform) pattern.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	:الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient ID: 93697	Patient Name English: Zanoobah Ahmed Negm Mohamed Negm
Age: ٣٨ سنة, ٢ شهر	2026/03/09 01:54:59 PM :Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: 38 years old female patient with pathologically proven invasive ductal carcinoma grade II

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: Minimal background enhancement.

ACR: b

Right breast:

- **Low energy (Non contrast) images**: middle 1/3 LIQ &LOQ irregular shaped spiculated dense lesions associated with architectural distortion.
- **Recombined (Post contrast) images**:
  - LOQ middle 1/3 irregular spiculated heterogenous moderate conspicuity mass enhancement measuring about 4.7 x 6 x 2.9 cm at its AP, TS and CC diameters and about 3.5 cm from the nipple (**Index lesion,**).
  - **LIQ** middle 1/3s irregular spiculated heterogenous moderate conspicuity mass enhancement measuring about 2.7 x 3.6 x 1.4 cm at its AP, TS and CC diameters and about 4.5 cm from the nipple
  - **Complementary US**:
  - large irregular shaped spiculated hypoechoic lesion located from 3-6 clock position
  - similar smaller from 8-9 o'clock is noted
  - Few enlarged axillary lymph node at level I with focal cortical thickening, largest one measuring about 24 x 19 mm with focal cortical thickening measuring about 10 mm.

Left breast:

- **Low energy (Non contrast) images** No asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images**: no pathological mass or non-mass enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**
  - No solid or cystic lesions.
  - No enlarged axillary LNs.

IMPRESSION:

- **left BREAST:** (BIRADS 6= pathological proven) two enhancing malignant masses as described above.
- **Right BREAST**: (BIRADS 2) normal study.

Best regards,

Dr. LAMIAA ADEL, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جوستاف روسي

Patient's Name:	**zanouba ahmed nagm ahmed**
Date:	**2026-04-08**
Referred by:	Prof.Dr. cap+c
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

٩١٤٨

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 43 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- ❖ **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**
- ❖ **Fatty hepatomegaly.**

Dr.sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE.CT_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name: زينب [illegible]
MRN: 9148

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5/9/26 Time of delivery: 5:30 Transfusion start time: 7:00 End Time: 9:50
Blood Group & RH Type: (B+) Type of blood unit: (B+) Blood unit No: 2727

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	7:00	36-4	85	100	16	108/79	0
After 5 minutes	7:5	36-5	86	100	16	108/77	0
After 10 minutes	7:10	36-6	87	99	17	110/79	0
After 15 minutes	7:15	36-6	89	99	17	115/80	0
After 30 minutes	7:30	36-6	90	98	17	119/82	0
After 45 minutes	7:45	36-7	92	99	16	122/83	0
After 60 minutes	8	36-7	93	100	17	121/84	0
After 90 minutes	8:30	36-8	95	100	18	125/85	0
After completion of transfusion	9	36-8	95	98	18	126/86	0
After 5 minutes from completion of transfusion	9:5	37	94	99	19	130/84	0
After 1 hour from completion of transfusion	10	36-6	96	98	20	132/86	0
After 2 hours from completion of transfusion	10:35	36-7	98	100	18	128/83	0

Nurse Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said Date: 5/9/26 Time: 7:55

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Blood /Blood Components Transfusion Consent
اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه بانى على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: : .....

اسم الشاهد: : .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: : .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Diagnosis: D.C Unit: Day Care Diet Type: Normal

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Norhan Said	Norhan Said	
							7:00

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL ÉGYPTE

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

2567	زنوبه احمد نجم
MRN:	9148
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:53:47 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2727	Z5945121		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:53 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:53 م

جوستاف روسي

Patient's Name: zanouba ahmed nagm ahmed
Date: 2026-04-08
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٩١٤٨

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 43 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Opinion:

- **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**
- **Fatty hepatomegaly.**

Dr.sherif Wagdy

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform) pattern.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name: زينب [illegible]
MRN: 9148

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5/9/26 Time of delivery: 5:30 Transfusion start time: 7:00 End Time: 9:50
Blood Group & RH Type: (B+) Type of blood unit: (B+) Blood unit No: 2727

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	7:00	36-4	85	100	16	108/79	0
After 5 minutes	7:5	36-5	86	100	16	108/77	0
After 10 minutes	7:10	36-6	87	99	17	110/79	0
After 15 minutes	7:15	36-6	89	99	17	115/80	0
After 30 minutes	7:30	36-6	90	98	17	119/82	0
After 45 minutes	7:45	36-7	92	99	16	122/83	0
After 60 minutes	8	36-7	93	100	17	121/84	0
After 90 minutes	8:30	36-8	95	100	18	125/85	0
After completion of transfusion	9	36-8	95	98	18	126/86	0
After 5 minutes from completion of transfusion	9:5	37	94	99	19	130/84	0
After 1 hour from completion of transfusion	10	36-6	96	98	20	132/86	0
After 2 hours from completion of transfusion	10:35	36-7	98	100	18	128/83	0

Nurse Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said Date: 5/9/26 Time: 7:55

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Blood /Blood Components Transfusion Consent
اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه بانى على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: : .....

اسم الشاهد: : .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: : .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Diagnosis: D.C Unit: Day Care Diet Type: Normal

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Norhan Said	Norhan Said	
							7:00

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL ÉGYPTE

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

2567	زنوبه احمد نجم
MRN:	9148
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:53:47 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2727	Z5945121		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:53 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:53 م

جوستاف روسي

Patient's Name: zanouba ahmed nagm ahmed
Date: 2026-04-08
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٩١٤٨

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 43 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Opinion:

- **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**
- **Fatty hepatomegaly.**

Dr.sherif Wagdy

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform) pattern.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name: زينب [illegible]
MRN: 9148

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5/9/26 Time of delivery: 5:30 Transfusion start time: 7:00 End Time: 9:50
Blood Group & RH Type: (B+) Type of blood unit: (B+) Blood unit No: 2727

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	7:00	36-4	85	100	16	108/79	0
After 5 minutes	7:5	36-5	86	100	16	108/77	0
After 10 minutes	7:10	36-6	87	99	17	110/79	0
After 15 minutes	7:15	36-6	89	99	17	115/80	0
After 30 minutes	7:30	36-6	90	98	17	119/82	0
After 45 minutes	7:45	36-7	92	99	16	122/83	0
After 60 minutes	8	36-7	93	100	17	121/84	0
After 90 minutes	8:30	36-8	95	100	18	125/85	0
After completion of transfusion	9	36-8	95	98	18	126/86	0
After 5 minutes from completion of transfusion	9:5	37	94	99	19	130/84	0
After 1 hour from completion of transfusion	10	36-6	96	98	20	132/86	0
After 2 hours from completion of transfusion	10:35	36-7	98	100	18	128/83	0

Nurse Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said Date: 5/9/26 Time: 7:55

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Blood /Blood Components Transfusion Consent
اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه بانى على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: : .....

اسم الشاهد: : .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: : .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Diagnosis: D.C Unit: Day Care Diet Type: Normal

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Norhan Said	Norhan Said	
							7:00

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL ÉGYPTE

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

2567	زنوبه احمد نجم
MRN:	9148
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:53:47 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2727	Z5945121		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:53 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:53 م

جوستاف روسي

Patient's Name: zanouba ahmed nagm ahmed
Date: 2026-04-08
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٩١٤٨

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 43 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Opinion:

- **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**
- **Fatty hepatomegaly.**

Dr.sherif Wagdy

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform) pattern.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name: زينب [illegible]
MRN: 9148

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5/9/26 Time of delivery: 5:30 Transfusion start time: 7:00 End Time: 9:50
Blood Group & RH Type: (B+) Type of blood unit: (B+) Blood unit No: 2727

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said	☐ Charge Nurse	Name & ID: AZZasaid Signature: 3012

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	7:00	36-4	85	100	16	108/79	0
After 5 minutes	7:5	36-5	86	100	16	108/77	0
After 10 minutes	7:10	36-6	87	99	17	110/79	0
After 15 minutes	7:15	36-6	89	99	17	115/80	0
After 30 minutes	7:30	36-6	90	98	17	119/82	0
After 45 minutes	7:45	36-7	92	99	16	122/83	0
After 60 minutes	8	36-7	93	100	17	121/84	0
After 90 minutes	8:30	36-8	95	100	18	125/85	0
After completion of transfusion	9	36-8	95	98	18	126/86	0
After 5 minutes from completion of transfusion	9:5	37	94	99	19	130/84	0
After 1 hour from completion of transfusion	10	36-6	96	98	20	132/86	0
After 2 hours from completion of transfusion	10:35	36-7	98	100	18	128/83	0

Nurse Name & ID: Moinra said 3059 Signature: Moinra said Date: 5/9/26 Time: 7:55

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Blood /Blood Components Transfusion Consent
اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه بانى على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: : .....

اسم الشاهد: : .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: : .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9148
اسم المريض:	رنوه أحمد نعم محمد
تاريخ الميلاد:	06/09/1977
الرقم الطبي القديم:	null

Diagnosis: D.C Unit: Day Care Diet Type: Normal

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Norhan Said	Norhan Said	
							7:00

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL ÉGYPTE

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

2567	زنوبه احمد نجم
MRN:	9148
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:53:47 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2727	Z5945121		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:53 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:53 م

جوستاف روسي

Patient's Name: zanouba ahmed nagm ahmed
Date: 2026-04-08
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٩١٤٨

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 43 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 12 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Opinion:

- **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**
- **Fatty hepatomegaly.**

Dr.sherif Wagdy

Patient Name	: الأستاذه / زنوبه احمد نجم	Request No.	: 13004867
Patient No.	: 27709062100983	Request Date	: 04/02/2026
Path No.	: 343/26	Verification Date	: 15/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform) pattern.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Medical No. : 9770
Patient's Name: zanoba ahmed negim mohamed
Date: 2026-10-07
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA. No available previous DICOM images for comparison.

I- CHEST:

- Suspected left breast lesion measuring 50 x 29 mm for sono-mammography.
- Prominent left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 11 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 17 x 11 mm at the retrocaval region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Mesenteric area of fat stranding with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes denoting mesenteric panniculitis.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Right external iliac subcentimetric lymph node measuring 16 x 5 mm.
- No ascites.

Medical No. : 9770

Patient's Name: zanoba ahmed negim mohamed

Date: 2026-10-07

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Opinion:

- **Suspected left breast lesion for sono-mammography.**
- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**

Dr.sherif Wagdy